

Dispercepire il Mondo — Sintesi

Salute Mentale · Sessione 05

Tre blocchi in una lezione: semiologia (leggere i segni), funzioni cognitive (capire il motore), psicofarmacologia (capire lo strumento). Questa lezione è il vocabolario comune di tutto il modulo — ogni termine qui tornerà nelle prossime settimane.

Semiologia del comportamento

- **Segni** → indicatori oggettivi riscontrabili dal curante (febbre, tremore)
 - **Sintomi** → indicatori soggettivi riferiti dal paziente (dolore, angoscia)
 - **Apparenza e mimica**: **ipertimia** (mimica espressiva, fasi maniacali) · **amimia** (mimica assente, depressione/Parkinson) · **mimica discordante** (schizofrenia)
 - **Discorso**: non solo il contenuto — la velocità, il tono, il bisogno di stimolazione sono già dati clinici
 - **Cura di sé**: igiene, alimentazione, sonno, relazioni. **Monitorare i cambiamenti rispetto alla normalità personale del paziente**
 - **Disturbi del sonno**: **risvegli precoci** (disturbi umore) · **difficoltà ad addormentarsi** (disturbi ansiosi)
 - **Passaggi all'atto**: auto-aggressivi · etero-aggressivi · **fughe dissociative** (allontanamento post-trauma, amnesia dell'episodio — ≠ **allontanamento nelle demenze**)
 - **Disturbi psicomotori**: agitazione · **catatonìa** (perdita iniziativa motoria + ipertono muscolare) · tic · paracinesi · stereotipie
-

Semiologia dello stato mentale attuale

Coscienza

- **Cosciente** = sa chi è + sa dove è + reagisce all'ambiente
- Scala quantitativa: lucidità → ottundimento → torpore → sopore → coma
- Qualitative: stato confusionale · mania à potu · stato oniroide · automatismo · stupore · fenomeni dissociativi

Orientamento (nei tre domini)

- **Tempo** → più labile, può alterarsi senza patologia
- **Spazio** → già clinicamente significativo
- **Persona** (non so chi sono) → più grave

Spazio + tempo alterati insieme → sospetto di problematica cerebrale

Memoria

- **Sensoriale**: 1-2 sec (iconica = visiva, ecoica = uditiva)
- **A breve termine**: 20-30 sec, 5-9 elementi
- **Di lavoro**: rielabora le info (≠ MBT) · rientra nelle funzioni esecutive
- **A lungo termine**: implicita (automatismi) · esplicita: episodica (vita) + semantica (nozioni)
- Disturbi quantitativi: ipomnesia · **amnesia anterograda** (dopo evento indice) · **amnesia retrograda** (prima dell'evento indice) · ipermnesia
- Disturbi qualitativi: falsi ricordi · **confabulazioni (sindrome di Korsakoff)** · déjà vu/vécu

Attenzione

- **Selettiva**: focus su un obiettivo, esclude il resto (**in ansia: tunnel sul problema**)
- **Divisa**: più fonti contemporaneamente, solo con schemi cognitivi diversi
- **Sostenuta**: attenzione a lungo su compiti monotoni; **si riduce con l'invecchiamento**

Percezione

- **Sensazione** → dato grezzo dai sensi · **Percezione** → rielaborazione soggettiva del cervello
 - Distorsioni quantitative: iperestesia · ipoestesia
 - Distorsioni qualitative: micropsia · macropsia · dismegalopsia
 - **Illusione** → interpretazione erranea di uno stimolo reale (affettiva, da completamento) — **non necessariamente patologica**
 - **Allucinazione** → percezione senza oggetto — la persona la vive come reale
 - **Agnosia** → i sensi funzionano, ma il cervello non riconosce l'oggetto
(**prosopagnosia** = volti; **anosognosia** = proprio stato di malattia)
-

Funzioni cognitive

Le principali: memoria · attenzione · funzioni esecutive (problem solving, pianificazione, inibizione) · linguaggio · funzioni gnoseo-percettive · prassie · emozioni.

- **Lo stesso comportamento può derivare da lesioni diverse → osservazione clinica essenziale**
 - I **neurotrasmettitori** (dopamina, serotonina, GABA, ecc.) regolano la comunicazione neuronale — **molte patologie psichiatriche sono legate ai loro squilibri**
-

Psicofarmacologia

- La psicofarmacologia moderna nasce nel **1952** (**clorpromazina**, primo antipsicotico)
- **Farmacodinamica** → come agisce il farmaco · **Farmacocinetica** → come viene assorbito/eliminato
- **Emivita** = tempo per ridurre del 50% il farmaco nel sangue → **determina gli intervalli di somministrazione**

Le 4 classi principali

Classe	Uso principale	Note importanti
Antipsicotici	Sintomi positivi (deliri, allucinazioni)	Tipici (1a gen., più effetti coll.) · Atipici (anni '90, meno effetti coll.)
Antidepressivi	Depressione, ansia, OCD, altro	Bifasici: effetto dopo 2-3 settimane · rischio di interruzione precoce
Ansiolitici	Ansia acuta	Benzodiazepine: effetto immediato ma possibile dipendenza a lungo termine
Stabilizzatori umore	Disturbo bipolare	Litio: efficace ma tossico se sovradosato · richiedono monitoraggio

- Non dedurre la diagnosi dalla terapia farmacologica
- Il farmaco è **una parte** della presa a carico integrata — non risolve tutto da solo
- Evitare sia il rifiuto totale degli psicofarmaci che l'illusione che risolvano ogni problema

Da ricordare: Segni ≠ Sintomi · Illusione ≠ Allucinazione (stimolo reale vs. assenza di oggetto) · **Emivita** = parametro chiave per l'operatore sociale nella gestione della terapia farmacologica